

1. Зняття шкірних швів

Сценарій.

Ви черговий хірург лікарні. У хворого 8-а післяопераційна доба після ургентної операції (лапаротомія), оперуючим лікарем було призначено зняття хірургічних швів з післяопераційної рани.

Скарги під час госпіталізації: на переймоподібні болі у животі, блювання, відсутність стільця, виражену загальну слабкість.

Анамнез захворювання: Хворий поступив на 2 добу хвороби зі скаргами на біль в череві, нудоту, багаторазове блювання, невідходження газу та стулу. Два року тому хворий оперований з приводу гострого флегмонозного апендициту, місцевого перитоніту. Хворий був обстежений ургентно під час надходження до клініки:

Анамнез життя: Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій - 2022 році апендектомія. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.

Об'єктивно під час госпіталізації: стан середнього ступеня, у свідомості, положення активне. Шкіра блідо-рожева, суха. Ріст 180 см, вага 83 кг. Периферичний набряків немає. Грудна клітина правильної форми, еластична, безболісна, симетрично бере участь в акті дихання. Аускультативно у легенях везикулярне дихання визначається над усієї поверхнею легень. Тони серця ясні ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС=Пс=96 за хв., АТ ліва рука 110/70 мм рт.ст., АТ права рука 110/70 мм рт.ст. Живіт здутий, асиметричний, не приймає участь у акті дихання. При пальпації м'який, болючий в правій здухвинній ділянці. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом Валя позитивний. Симптом Щьоткіна-Блюмберга негативний. Аускультативно - перистальника вяла, "шум плеску" позитивний. Ділянка попереку без патології. Нирки не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Випорожнення не було. Сечовипускання без особливостей.

Додатково:

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення	Норма
Гемоглобін (г/л)	152	120-140
еритроцити (10 ¹² /л)	4,8	3,9-4,7
Кольоровий показник	1,1	0,85-1,15

Тромбоцити (10 ⁹ /л)	215	180-320
Лейкоцити (10 ⁹ /л)	18,0	4,0-9,0
Лімфоцити %	5	19-37%
Еозинофіли %	0	0,5-5
Паличкоядерні нейтрофіли %	15	1-6%
Сегментоядерні нейтрофіли %	76	47-72%
Моноцити %	4	3-11%
ШЗЕ	25	5-15

Рентгенологічне дослідження органів черевної порожнини.



12. Інструкція для стандартизованого пацієнта (за необхідності, якщо це передбачено умовами роботи на станції).

№п/п	Дії	Текст
1.Комунікативні навички		
1.1	Привітатися.	Доброго дня.
1.2	Ви даєте свою згоду на проведення клінічного обстеження?	Так
Збір скарг та анамнезу		
2.1	Які у Вас скарги?	на переймоподібні болі у животі, блювання, відсутність стільця, виражену загальну слабкість.
2.2	Коли з'явилися скарги, що з Вами трапилось?	Хворий поступив на 2 добу хвороби зі скаргами на біль в череві, нудоту, багаторазове блювання, невідходження газу та стулу. Два року тому хворий оперований з приводу гострого флегмонозного апендициту, місцевого перитоніту.
2.3	Якими захворюваннями перехворіли? Чи є алергія? Чи були операції?	Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій - 2022 році апендектомія. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Огляд з верифікацією виявлених патологічних змін.	Пацієнт у свідомості, положення активне. Шкіра блідо-рожева, суха. Живіт здутий, асиметричний, не бере участі в акті дихання. Ознак жовтяниці, висипань або видимих гриж не виявлено. Післяопераційна рана без ознак гіперемії чи інфільтрації, загоєння відбувається первинним натягом
3.2	Пальпація з верифікацією	Живіт при пальпації м'який, болючий в правій здухвинній ділянці. Виявлено позитивний

	виявлених патологічних змін	симптом Валя, що свідчить про накопичення рідини або газу. Симптом Щьоткіна-Блюмберга негативний. Післяопераційна рана не інфільтрована, ознак розходження швів немає
3.3	Перкусія з верифікацією виявлених патологічних змін	При перкусії живота — тимпаніт над більшістю ділянок, посилений над петлями кишківника, що відповідає кишковому метеоризму. Печінкова тупість збережена.
3.4	Аускультация з верифікацією виявлених патологічних змін	Аускультативно — перистальтика вяла, місцями не вислуховується, позитивний симптом "шуму плеску", що може свідчити про порушення пасажу в кишківнику, можливий розвиток спайкової кишкової непрохідності.

4.Діагностика

4.1	Проаналізувати клінічний аналіз крові	Виявлено лейкоцитоз ($18,0 \times 10^9/\text{л}$), нейтрофіліоз (паличкоядерні — 15%, сегментоядерні — 76%), що свідчить про виражену запальну реакцію. Знижений рівень лімфоцитів (5%) та підвищена ШЗЕ (25 мм/год) — додаткові ознаки активного патологічного процесу, ймовірно, післяопераційного ускладнення.
4.2	Проаналізувати оглядову рентгенографію органів грудної клітини	На оглядовій рентгенограмі виявлено симптом "чаш" Клойбера, рівні рідини у розтягнених кишкових петлях, відсутність газу в прямій кишці — характерні ознаки динамічної або механічної непрохідності.
4.3	Встановити попередній клінічний діагноз	Післяопераційна (спайкова) кишкова непрохідність.

5. Визначення тактики ведення та лікування

5.1	Медикаментозна терапія, фізіотерапія, особливості харчування	Ургентна госпіталізація у хірургічне відділення. Заборона їжі та пиття до операції. Декомпресія кишківника через назогастральний зонд, венозний доступ — 0.9% NaCl, 5% глк, знеболення (анальгін 50% 2мл). Оперативне лікування.
-----	--	--

6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя

6.1	Рекомендувати профілактичні заходи	Після стабілізації стану рекомендовано дотримання щадної дієти, уникання фізичних навантажень протягом щонайменше 6 тижнів. Профілактика спайкової хвороби — рання активізація післяоперацій, дотримання режиму харчування та дефекації, достатнє живання рідини.
7.Інше		
7.1	Інформування пацієнта про можливі ризики хвороби	Пацієнту надано роз'яснення щодо можливих ускладнень: рецидивуюча кишкова непрохідність, необхідність повторного оперативного втручання.

Чек-лист до практичної навички «Зняття шкірних швів»

№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування лікар-пацієнт, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки хірургічним способом (лікар в рукавичках), надіти стерильний одяг, окуляри	Виконати
4	Зняти пов'язку, виконати огляд рани, визначити кількість швів, які будуть зніматися	Виконати/Сказати
5	Коректно обробити місце швів розчином антисептику (широко марлевою серветкою у пінцеті, другою марлевою серветкою у пінцеті)	Сказати
6	Коректно виконати зняття швів:	Виконати/
	- вузол шва захопити пінцетом і трохи підняти - нитку, що з'явилася над шкірою, перерізати ножицями - без зусилля витягнути кінчик нитки із вузлом, шов злегка відтягнути пінцетом - перевірити цілісність шкірних покривів	Сказати
7	Обробити рану антисептиком	Сказати

8	Накрити поверхню рани стерильною серветкою, зафіксувати лейкопластиром	Виконати
9	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

